



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : وفاء محمد عبد الخالق محمد

العنوان : ش الاعتماد

الحي / المدينة : امبابة

المحافظة : الجيزة

تاريخ تسجيل الإستمارة : 26-09-2026

رقم البطاقة : 26406272101307 رقم التليفون : 01099505788

العمر (تاريخ الميلاد) : 27-06-1964 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (.....) التوقيع: (.....)

المقرر بما فيه (.....) التوقيع: (.....)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص :

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : التوقيع :
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : التوقيع :

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

..... د/..... د/..... د/..... د/.....

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى : قسم :
جهة العلاج : نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: وفاء محمد عبد الخالق محمد National ID: 26406272101307	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



Dms

مع سوار على الشرس
مع هرمون اراميس
مع صر يد منه الاعرجات والاصومات



Patient Name : الأستاذ / وفاء محمد عبدالحق محمد
Patient No. : 26406272101307
Path No. : 1815/24
Sex : Female
Age : 59 Y
Referring Doc :

Request No. : 13002390
Request Date : 30/05/2024
Verification Date : 27/06/2024
Financial Category : جوستاف روسي - نفقة الدولة
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical data: Left axillary mass
Nature of Specimen : Left WLE & SLNB.

Gross:

WLE measured 9x8.5x4 cm, covering skin 8.5x1cm.
• Tumor extent: Two well circumscribed masses measured 2.7x2.5x2 cm and 2x2x1 cm , located 3 cm away from each other.
o Skin involvement: No
• Distance from margins: 0.1 cm from inferior margin (least)
• Lymph nodes number and size: Multiple fibrofatty tissue pieces measured 5x5x2 cm, entangling 6 nodes measured up to 2x1 cm. Also detected two intramammary lymph nodes measured up to 1x0.5 cm.

Microscopic:

Examination of the two detected masses revealed metastatic lymph nodes showing extensive tumor deposits of metastatic carcinoma. No extra-capsular extension. The two detected intra-mammary nodes were free reactive nodes.
Examination of dissected SLNs revealed Free reactive Nodes (0/6).

Diagnosis:

Left axillary mass, WLE & SLNs:
- Two Metastatic lymph nodes.
- Free two intramammary lymph nodes
- Free nodes dissected as (SLNs) (0/6).
- Free resection margins.

Comment:

- Extensive repeated dissection revealed No primary mass in the limit of the wide local

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Printing Date : 19/07/2025 09:21:25

Page 1 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name	: الأستاذ / وفاء محمد عبدالحق محمد	Request No.	: 13002390
Patient No.	: 26406272101307	Request Date	: 30/05/2024
Path No.	: 1815/24	Verification Date	: 27/06/2024
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف روسي - نفقة الدولة
Age	: 59 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

excision received. Patient has a previous pathology report (Path No 1241/24) showed:
Positive ER: score 7/8 . Positive PR: score 8/8, compatible with breast primary.
- Case for clinical and radiological correlation.

Prof. Gamal Abdelaty

Signature

Dr. Marwa Mahmoud

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Printing Date : 19/07/2025 09:21:25

Page 2 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

A Patient ID:

1. Name: *Dr. Huda Ali*

2. ID Number: *20106272101307*

MDT form

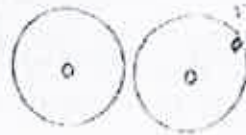
3. Medical number:

Female

03203335
6/2/2024

Patient Age: *60 Y*

1310/2024



Family history:

None

Phone:

01095505783

CME

Marital status:

Married

NRS Score:

GROUP

Comorbidity:

None

Menopausal status:

Initial STAGE

Reason of MDT

Date of MDT

15/05/2024

Breast Imaging:

IL Breast BIRADS 4 axillary tail

Clinical data

Mt+ Workup:

free

DX

ER

7/8

PR

8/8

Her 2 Neu

0

SISH

Ki67

1

2

N

0

N

0

Sonemammography

PATIENT HISTORY

MDT OUTCOME & PLAN

IN VIEW of having C12 N0 M0 luminal disease :for upfront LT WLE & SLNB

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

Psychiatric

SIGNATURE

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Nutrition

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

15/05/2024

Patient Name: Wafaa Mohamed Abdel Khalek Mohamed	Date : 08/05/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 60 Year(s)
Medical ID: 1316/2024	Pat ID: 53551

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Left axillary tail pathologically proved metastasis carcinoma of breast origin.

Technique

- Bilateral MLO and CC views.
- Bilateral 3D MLO views DBT (Digital Breast Tomosynthesis).
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- The breasts are almost entirely fatty (ACR A)
- No suspicious mass lesions, suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- Left axillary tail highly dense lesion.
- Complementary ultrasound showed left axillary tail well defined heterogenous mass lesion measuring about 27x17mm with highly internal vascularity seen within.
- no bilateral solid or cystic mass lesions.
- Normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific axillary LNs.

Opinion:

- Left axillary tail pathologically proved metastatic carcinoma (BIRADS 6)
- Right breast normal study (BIRADS 1).

• Signature Dr. Nehal Hamdy
• 08/05/2024 4:51 PM

Request No : 13029115
Request Date : 04/04/2012
Verification Date : 23/04/2012
Financial Category : 23,24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 84

Pathology Report

Clinical Data, Left axillary pathological lymph node

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected at 3/4/2024, 10:32 am.

Gross Examination:

Multiple grayish white tissue cores up to 1.5 cm, totally submitted.

Microscopic Examination:

* Histological type, Metastatic carcinoma in lymph node.

।प्रः

GATA3: Diffuse positive.

Fig. 1. 1985-86.

Left axillary path, * indicates stenosis (30 mm Hg and 40 mm Hg).

Metastatic carcinoma of primary breast origin.

For further IHC (ER, PR, Her2, Ki67)

Signature

Prof. Dr.Lubna Omar.

Dr. Menna Ne'it.

Verified by :

DR Menna Nabli

Printing Date: 24/04/2024 09:42:39

Page 1 of 1

Printing By : Al Mustafa

عمره ٤٠ (4) - المولد: ١٩٥٨ - (1958) - كوروش المولى - مصر - القاهرة -

Name: -Wafaa Mohamed A.F.A-Khaleik

Date:- 2/5/2024

R:24462

Dear, Prof. Dr

Post Contrast CT Scan Of the Chest, Abdomen & Pelvis With Oral and IV Contrast Revealed.

- ❖ A reported case of left sided para ductal carcinoma .
- ❖ Kindly for correlation with non available old images for comparison

I- Chest :-

- Thin atelectatic band is noted at the anterior segment of right lower lung lobe
- No definite pulmonary nodule , mass or cavity lesion
- No pleural effusion
- Average cardiac size with no pericardial collection
- No enlarged hilar or mediastinal LNs could be noted
- A well defined soft tissue mass lesion is noted within the confinement of left breast

Opinion :-

- Right lower pulmonary atelectatic band is noted
- No definite pulmonary metastasis

II- Abdomen & Pelvis :-

- Enlarged liver with diffuse low attenuation . No focal lesion or dilated HBRs.
- Bulky uterus showing few calcified fibroids
- Patent main portal vein and its central branches .
- Average sized spleen showing no definite focal lesions .
- Normal CT appearance of the pancreas, adrenal glands , kidneys , aorta and IVC
- Intact pelvic organs
- No retro-cranial or retro-peritoneal lymph nodes are noted
- No ascites.

Opinion :-

- Enlarged fatty liver .
- Bulky uterus with few calcified fibroids for further U/S assessment

Dr. Fatma Naeem Prof. Dr. Tamer Ahmed Kamal
R.A

العمارة الإسلامية في مصر - د. محمد مصطفى

Parent Name _____

Patient No.

Page 10

2.

430

Referencing Doc.

المستند / رقم ١٠٠ - ح. ١٢٣٤

25466272101307

124 1/24

Female

59 Y

Request No 13009115

Request Date	01/04/2024
--------------	------------

Verification Date 28/04/2024

Financial Category	2019/2020	2020/2021
--------------------	-----------	-----------

Department Out Patient

2010 01 01 00:00:00

0029-5508/96/0005-0000\$05.00/0

57.4-100% of the cells are

3, strong). Total score (from 0 to 3)

Reference: ASCO 640.

the invasive tumor cells. IHC 1+ as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within $< 10\%$ of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within $< 10\%$ of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense and within $< 10\%$ of the invasive tumor cells.

Signature _____

Prof. Dr. Lubna Omar

Dr. Duaa Mohamed

Verified by

DR. Mohamed Nabil

Printing Date: 01/05/2015 08:51:22

Page 2 of 11

Printed By: marwa roshan and youss

3,1542
at - Calo. Exp.

Genitourinary Initiative for Women's Health - Pathology Lab
 المبادرة النسائية لأمراض النساء - معمل الباثولوجي

Patient Name	الأستاذة / رواء محمد عبدالحق محمد	Request No.	13009115
Patient No.	26406272101307	Request Date	04/04/2024
Pain No	1241/24	Verification Date	28/04/2024
Sex	Female	Financial Category	وراء مثر السلام - نفقة الدولة
Age	59 Y	Department	Out Patient
Referring Doc.		Registered by	marwa mohamed youssif

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: 'Her2'

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013. IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, Intense < 10% of tumor cells.

Signature
 Prof. Dr. Lubna Omar.
 Dr. Doha Mohamed.

Verified by:
 DR. Menna Nabil

Printing Date: 01/05/2024 08:52:21

Page 2 of 3

Printed By: marwa mohamed youssif

CAP:

عنوان (4) - دور الأمل - مبنى رقم (563) - الدور الأرضي - معمل فحوصات - القاهرة - مصر
 Room No (4) - First Floor Building No 563 - Nile Corniche - Al-Nor El-Qadima - Cairo, Egypt